Documento de Requerimientos — Sistema Web de Historias Clínicas

Versión 0.1 (borrador) · Octubre de 2026 · Elaborado por el equipo de ingeniería de requerimientos y front end

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requerimientos del sistema web de historias clínicas. Sirve como base común para el equipo de requerimientos y front end y para las 2 personas del equipo encargadas del resto del desarrollo (back end y base de datos).

1.2 Alcance

El sistema permitirá registrar, consultar, actualizar, enviar y exportar historias clínicas de pacientes en un entorno web, con control de acceso por roles, trazabilidad completa de las acciones y cumplimiento de la normativa colombiana de tratamiento de datos personales. El agendamiento de citas médicas queda fuera del alcance inicial y se contempla como funcionalidad futura.

1.3 Marco normativo

El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 y la Ley 2015 de 2020 (régimen general de protección de datos personales). Los datos de historias clínicas son datos sensibles, por lo que se exige un nivel de protección reforzado.

Normas relacionadas que el equipo debe verificar y confirmar con asesoría legal o docente antes de darlas por aplicables: Resolución 1995 de 1999 (manejo y conservación de historias clínicas), Ley 2015 de 2020 (historia clínica electrónica interoperable) y Resolución 866 de 2021 (interoperabilidad). Este documento no constituye asesoría legal.

1.4 Definiciones

Término	Definición
Historia clínica (HC)	Registro de la atención y el estado de salud de un paciente: ingreso, diagnósticos, tratamientos, evoluciones y recomendaciones.
Paciente	Persona cuya información clínica se registra en el sistema.
Profesional	Usuario del sistema con rol de médico o auxiliar.
Trazabilidad	Capacidad de reconstruir quién hizo qué, sobre qué registro y cuándo.
EPS	Entidad Promotora de Salud.
Super admin	Usuario con permisos de administración total del sistema.

2. Descripción general

2.1 Roles de usuario

Rol	Descripción
Super admin	Por ahora corresponde a los 3 desarrolladores del proyecto. Administra el sistema.
Doctor / Médico	Puede revisar, actualizar, modificar y enviar las historias clínicas de cualquier paciente registrado. Autoriza la entrega de resúmenes.
Auxiliar	Puede registrar historias clínicas y consultarlas mediante el número de cédula del paciente.

2.2 Matriz de permisos (propuesta inicial)

Acción	Super admin	Médico	Auxiliar
Iniciar sesión con credenciales individuales	Sí	Sí	Sí
Registrar una historia clínica nueva	Por definir	Sí	Sí
Consultar una HC por cédula	Por definir	Sí	Sí (alcance por definir, ver PA-01)
Ver diagnósticos, tratamientos y evoluciones	Por definir	Sí	Por definir (ver PA-01)

Acción	Super admin	Médico	Auxiliar
Modificar una HC	No	Sí	No
Enviar una HC	No	Sí	No
Autorizar un resumen de HC	No	Sí	No
Gestionar usuarios y roles	Sí	No	No
Consultar registros de auditoría	Sí	Por definir	No

Las celdas marcadas como «Por definir» deben validarse con el equipo antes de implementarse.

3. Requisitos funcionales

Prioridad: Alta, Media o Baja.

3.1 Autenticación y control de acceso

ID	Requisito	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir a cada profesional iniciar sesión con un usuario y una contraseña individuales.	Alta
RF-02	El sistema debe asignar a cada usuario un rol (super admin, médico o auxiliar) y restringir las funciones y vistas según ese rol.	Alta
RF-03	El sistema debe cerrar la sesión de forma automática tras un periodo de inactividad (duración por definir).	Alta
RF-04	El sistema debe permitir cerrar sesión manualmente.	Alta
RF-05	El sistema debe impedir el uso de cuentas compartidas: un usuario corresponde a un solo profesional.	Alta
RF-06	El super admin debe poder crear, desactivar y asignar roles a usuarios.	Alta

3.2 Gestión de historias clínicas

ID	Requisito	Prioridad
RF-07	El auxiliar y el médico deben poder registrar una historia clínica nueva para un paciente.	Alta
RF-08	El auxiliar y el médico deben poder buscar una historia clínica por número de cédula del paciente.	Alta
RF-09	El médico debe poder consultar la historia clínica de cualquier paciente registrado en la base de datos.	Alta
RF-10	El médico debe poder actualizar y modificar historias clínicas. Cada modificación debe generar una nueva versión sin sobrescribir la anterior.	Alta
RF-11	El médico debe poder enviar una historia clínica cuando corresponda legalmente (ver RF-24 a RF-26).	Alta
RF-12	El sistema debe mostrar en cada historia clínica el historial de versiones, indicando autor, fecha y hora de cada cambio.	Alta
RF-13	El sistema no debe permitir eliminar registros clínicos. Cualquier baja debe ser lógica y quedar registrada.	Alta

3.3 Contenido clínico de la historia

ID	Requisito	Prioridad
RF-14	La historia clínica debe incluir un examen de ingreso del paciente.	Alta
RF-15	La historia clínica debe permitir registrar recomendaciones.	Alta

ID	Requisito	Prioridad
RF-16	La historia clínica debe permitir registrar las enfermedades de base relevantes del paciente.	Alta
RF-17	El sistema debe permitir solicitar la historia clínica de una EPS previa. Esta solicitud es opcional y no debe bloquear el registro ni la atención.	Media

3.4 Corrección de errores en modificaciones

ID	Requisito	Prioridad
RF-18	Cuando se produzca un error al modificar una historia clínica, el sistema debe aplicar un tiempo de espera (timeout) de 1 día sobre la información afectada.	Media
RF-19	El sistema debe registrar en la auditoría el error, el momento en que se aplicó el timeout y el momento en que terminó.	Media
RF-20	El sistema debe informar al usuario, en la interfaz, que la información afectada está en periodo de espera.	Media

El comportamiento exacto de este mecanismo está pendiente de aclaración (ver PA-03).

3.5 Trazabilidad y auditoría

ID	Requisito	Prioridad
RF-21	El sistema debe registrar cada ingreso al sistema, con usuario, fecha y hora.	Alta
RF-22	El sistema debe registrar cada consulta, modificación y descarga de una historia clínica, indicando usuario, paciente afectado, acción, fecha y hora.	Alta
RF-23	Los registros de auditoría no deben poder modificarse ni eliminarse por ningún rol.	Alta

3.6 Entrega y exportación de información

ID	Requisito	Prioridad
RF-24	El sistema debe permitir exportar una historia clínica completa de forma segura cuando corresponda legalmente (formato por definir).	Alta
RF-25	Un resumen de historia clínica solo puede generarse o entregarse con permiso explícito del médico.	Alta
RF-26	El sistema debe ofrecer un flujo de solicitud y aprobación de resúmenes: una persona solicita, el médico aprueba o rechaza, y el resultado queda registrado en la auditoría.	Alta

4. Requisitos no funcionales

Los requisitos RNF-01 a RNF-08 corresponden a los requisitos de seguridad bajo la Ley 1581.

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Accesos restringidos	Cada profesional debe tener usuario y contraseña individuales, con permisos según su función. Las contraseñas deben almacenarse protegidas (nunca en texto plano) y cumplir una política de complejidad.
RNF-02	Trazabilidad	Debe poder identificarse quién ingresa, consulta, modifica o descarga una historia clínica, con fecha y hora.

ID	Categoría	Requisito
RNF-03	Seguridad	La información debe protegerse contra accesos no autorizados, pérdida, filtración y alteración. Las comunicaciones deben ir cifradas y los datos sensibles protegidos en almacenamiento.
RNF-04	Integridad	Los registros clínicos no pueden modificarse ni eliminarse sin dejar trazabilidad.
RNF-05	Confidencialidad	Personal no autorizado no debe poder consultar diagnósticos, tratamientos ni evoluciones.
RNF-06	Almacenamiento y respaldo	Deben existir copias de seguridad periódicas, mecanismos de recuperación y conservación de la información conforme a los plazos legales.
RNF-07	Entrega de información	La consulta y exportación de historias clínicas debe ser segura y solo ocurrir cuando corresponda legalmente.
RNF-08	Interoperabilidad	Deben contemplarse los requisitos técnicos aplicables para el intercambio seguro de información clínica con otros sistemas.
RNF-09	Usabilidad	La interfaz debe ser clara para personal de salud, con vistas diferenciadas por rol y mensajes de error comprensibles.
RNF-10	Compatibilidad	El front end debe funcionar en navegadores web modernos y adaptarse a distintos tamaños de pantalla (navegadores y dispositivos objetivo por definir).
RNF-11	Mantenibilidad	El front end debe ser modular y comunicarse con el back end mediante una API con contrato documentado.
RNF-12	Disponibilidad y rendimiento	Los niveles de disponibilidad y los tiempos de respuesta aceptables están por definir con el equipo.

5. Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	Una historia clínica pertenece a un paciente identificado por su número de cédula.
RN-02	Solo el médico puede modificar y enviar historias clínicas.
RN-03	El médico puede acceder a la historia clínica de cualquier paciente registrado.
RN-04	El auxiliar registra y consulta historias mediante la cédula; no modifica historias existentes.
RN-05	Ningún registro clínico se elimina. Toda modificación conserva la versión previa.
RN-06	La historia clínica de una EPS previa puede solicitarse, pero no es obligatoria.
RN-07	Un resumen de historia clínica requiere el permiso del médico.
RN-08	Un error al modificar información activa un timeout de 1 día sobre esa información.
RN-09	Toda acción de ingreso, consulta, modificación o descarga queda auditada con fecha y hora.

6. Requisitos futuros

ID	Requisito	Prioridad
RFF-01	El sistema permitirá el agendamiento de citas médicas.	Baja (futuro)
RFF-02	El sistema ofrecerá una vista de fechas en un calendario interactivo.	Baja (futuro)

No se implementarán en la fase actual, pero la arquitectura del front end debe permitir incorporarlos sin rediseñar la estructura general.

7. Supuestos y restricciones

- El equipo se compone de 5 personas: 3 desarrolladores (que actúan como super admin) y 2 personas adicionales. Los autores de este documento cubren requerimientos y front end.
- El sistema se ofrece como aplicación web con un back end y una base de datos que se desarrollan en paralelo.
- Se asume una API REST entre front end y back end; el contrato aún no está definido.
- El front end no sustituye la seguridad del back end: los permisos deben validarse siempre en el servidor.
- El front end no debe almacenar datos clínicos sensibles en el navegador de forma persistente.
- Las referencias normativas distintas de la Ley 1581 están pendientes de verificación legal.

8. Preguntas abiertas

ID	Pregunta	Impacto
PA-01	¿Qué información de la historia puede ver exactamente el auxiliar? ¿Solo datos de identificación o también el contenido clínico?	Confidencialidad y permisos
PA-02	¿Puede el super admin ver contenido clínico, o solo administrar usuarios y auditoría?	Confidencialidad
PA-03	¿Cómo funciona exactamente el timeout de 1 día? ¿Bloquea la información, la deja en revisión o retrasa la aplicación del cambio? ¿Quién puede levantarlo?	RF-18 a RF-20
PA-04	¿Quién puede solicitar un resumen de historia clínica (paciente, otra entidad, auxiliar)? ¿Cómo se identifica al solicitante?	RF-25 y RF-26
PA-05	¿En qué formato se exportan las historias clínicas (por ejemplo PDF) y quién puede descargarlas?	RF-24
PA-06	¿Cuál es la política de conservación y respaldo (plazos y frecuencia)?	RNF-06
PA-07	¿Qué estándar de interoperabilidad se usará para el intercambio de información clínica?	RNF-08
PA-08	¿Cuánto dura la sesión por inactividad y qué política de contraseñas se aplicará?	RF-03 y RNF-01
PA-09	¿Se registrará el consentimiento del paciente para el tratamiento de sus datos (autorización de tratamiento)?	Cumplimiento Ley 1581
PA-10	¿Quién solicita la historia de una EPS previa y cómo se registra su respuesta?	RF-17

9. Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción
0.1	Octubre de 2026	Borrador inicial a partir de los requisitos de seguridad, roles y funciones extras definidos por el equipo.